



Doença Inflamatória Intestinal Estratégia Terapêutica, Farmacologia e Manejo Avançado

Apostila 4 — Páginas 61 a 80 | Uma visão moderna, estratégica e orientada por metas para o manejo da DII, do diagnóstico ao tratamento avançado.

MÓDULO 4

GASTROENTEROLOGIA AVANÇADA

Agenda do Módulo

Este módulo aborda os fundamentos do tratamento moderno da DII, percorrendo desde os objetivos terapêuticos atuais até as estratégias farmacológicas mais avançadas disponíveis.

01

Objetivos e Metas

Treat to Target, fases do tratamento e monitoramento da doença

03

Farmacologia

Classes medicamentosas: 5-ASA, corticoides, imunomoduladores e biológicos

02

Individualização

Fatores prognósticos, perfil do paciente e personalização da terapia

04

Estratégias e Cirurgia

Step-up vs top-down, tratamento por gravidade e papel da cirurgia

Objetivos do Tratamento na DII — Visão Moderna

O tratamento da DII deixou de ser meramente sintomático e passou a ser **estratégico, orientado por metas claras e voltado para a modificação da história natural da doença**. Historicamente, o foco era aliviar dor, diarreia e sangramento. Contudo, observou-se que muitos pacientes evoluíam com complicações estruturais graves mesmo diante de melhora clínica inicial aparente.

Remissão Clínica

Desaparecimento dos sintomas, remissão livre de corticoides e melhora sustentada da qualidade de vida

Cicatrização da Mucosa

Mucosal healing — ausência de lesões endoscópicas e normalização de marcadores inflamatórios (PCR, calprotectina)

Prevenção de Complicações

Evitar estenoses, fístulas e risco de câncer colorretal associado à inflamação crônica

Redução de Eventos

Diminuição de hospitalizações, procedimentos cirúrgicos e incapacidade funcional ao longo da vida

📌 **Ponto-chave:** O objetivo central é **modificar a história natural da doença**, e não apenas controlar crises agudas. Tratar sintomas sem controlar a inflamação subclínica é insuficiente.

Treat to Target — Mudança de Paradigma

O conceito de **Treat to Target** representa uma das maiores evoluções no manejo da DII. Em vez de tratar reativamente — apenas quando o paciente piora —, define-se um alvo terapêutico preciso e ajusta-se o tratamento continuamente até que esse alvo seja atingido e mantido. Esse modelo exige monitoramento ativo, avaliação periódica com exames objetivos e decisões dinâmicas baseadas em evidências.

Os Quatro Alvos Principais

1 Remissão Clínica Sustentada

Ausência de sintomas por período prolongado, sem uso contínuo de corticoides

2 Remissão Endoscópica

Ausência de inflamação visível à colonoscopia — considerado o padrão-ouro atual

3 Biomarcadores Normalizados

PCR e calprotectina fecal dentro dos limites normais, refletindo ausência de inflamação ativa

4 Livre de Corticoides

Manutenção da remissão sem dependência de corticosteroides sistêmicos

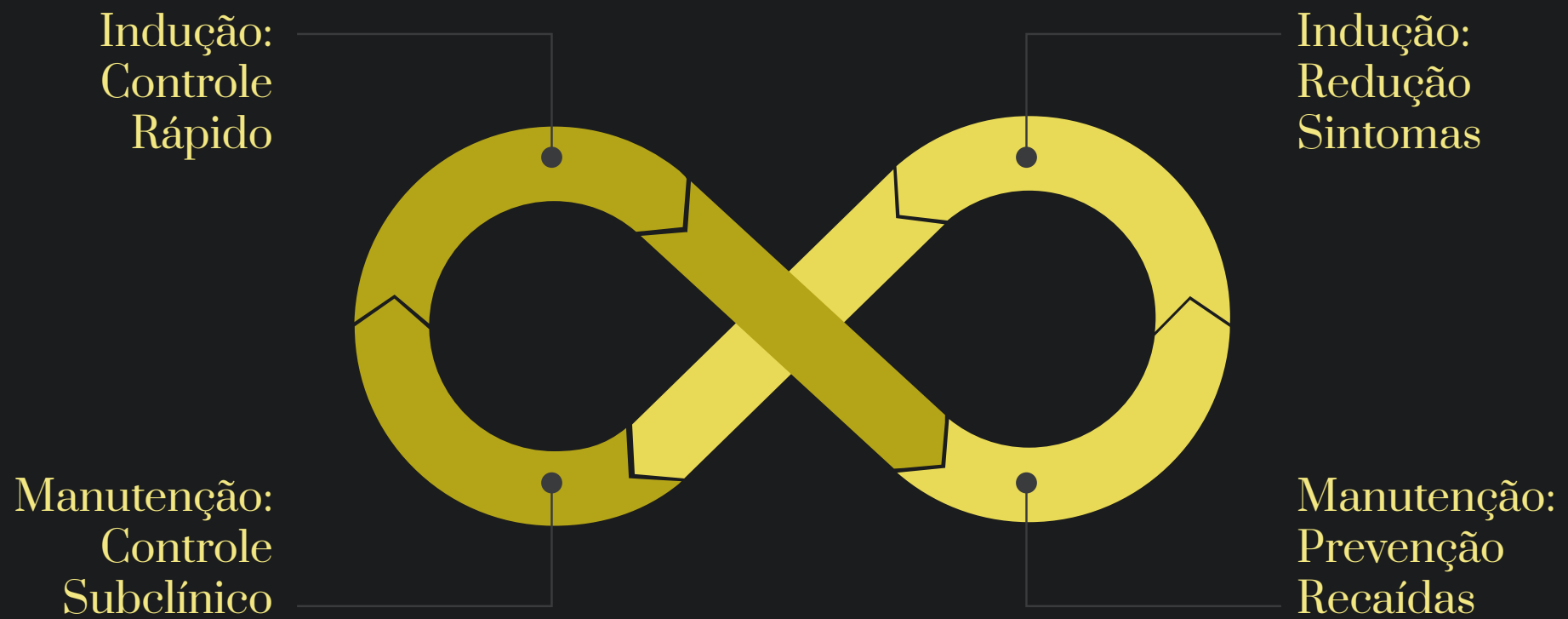
Por que isso importa?

Estudos demonstram que pacientes em remissão clínica podem ainda apresentar inflamação endoscópica ativa. Isso significa que avaliar apenas os sintomas subestima a atividade real da doença.

A abordagem Treat to Target mudou o papel do gastroenterologista: de reativo para **proativo e estratégico**. O objetivo é antecipar problemas antes que se tornem complicações estruturais irreversíveis.

- ❑ Monitoramento objetivo com calprotectina e endoscopia periódica é parte indissociável desse modelo.

Fases do Tratamento e Monitoramento



Um erro clínico comum é manter pacientes apenas na fase de indução sem definir uma estratégia sólida de manutenção. A ausência de tratamento de manutenção leva a recaídas frequentes e progressão das lesões.

Métodos de Monitoramento

→ Avaliação Clínica

Sintomas, frequência de evacuações, presença de sangue, dor abdominal e estado funcional geral

→ Marcadores Inflamatórios

PCR sérico e calprotectina fecal — ferramentas não invasivas essenciais para acompanhar a inflamação

→ Endoscopia

Padrão-ouro para avaliação de cicatrização da mucosa e detecção de displasia ou complicações

→ Exames de Imagem

Ressonância magnética e enterografia para avaliação transmural, especialmente na Doença de Crohn

📌 **Atenção:** O paciente pode estar aparentemente "bem" clinicamente, mas ainda apresentar inflamação ativa na mucosa intestinal. Essa dissociação clínico-endoscópica é um dos maiores desafios no manejo da DII e justifica o monitoramento objetivo e periódico.

Individualização do Tratamento

O tratamento da DII não é universal. Cada paciente apresenta um conjunto único de características que devem guiar as decisões terapêuticas. A tendência atual é uma medicina cada vez mais **personalizada, baseada em dados clínicos, genéticos e fenotípicos**.



Tipo de DII

Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa têm comportamentos, complicações e respostas terapêuticas distintas que exigem abordagens diferenciadas



Localização e Extensão

A topografia da doença (ileocólica, colônica, perianal) influencia diretamente a escolha da via de administração e da classe terapêutica



Gravidade e Comportamento

Doença inflamatória, estenosante ou fistulizante demandam estratégias e urgências terapêuticas completamente distintas



Perfil do Paciente

Idade, comorbidades, histórico terapêutico prévio, resposta a tratamentos anteriores e tolerância aos efeitos adversos são fatores determinantes

Fatores de Mau Prognóstico

A identificação precoce de pacientes com alto risco de evolução agressiva é fundamental para antecipar terapias mais eficazes e evitar complicações estruturais irreversíveis. Esses pacientes frequentemente se beneficiam de uma abordagem mais intensiva desde o início.

● Doença de Crohn

Diagnóstico em Idade Jovem

Maior tempo de exposição à inflamação e maior risco de complicações cumulativas ao longo da vida

Acometimento Perianal

Presença de fistulas, abscessos e fissuras perianais — marcadores de doença complexa e de difícil controle

Necessidade Precoce de Corticoide

Necessidade de corticoide logo no início da doença sugere atividade inflamatória intensa e risco de corticodependência

Doença Extensa ou Ileocólica

Comprometimento de grande extensão do trato digestivo, com maior risco de má absorção e desnutrição

Estenoses Precoces e Fístulas

Indicam comportamento penetrante ou estenosante, associado a maior necessidade cirúrgica

● Retocolite Ulcerativa

Pancolite

Extensão total da doença ao cólon está associada a maior risco de displasia, câncer e necessidade cirúrgica

Refratariedade Terapêutica

Falha ao tratamento convencional inicial, exigindo escalonamento rápido para terapias avançadas

Anemia Importante

Reflete sangramento crônico intenso e impacto sistêmico relevante da inflamação colônica ativa

Inflamação Intensa

Atividade endoscópica e histológica severa, com ulcerações profundas e perda significativa da mucosa

Hospitalizações Frequentes

Indicam doença de difícil controle ambulatorial e risco aumentado de complicações agudas

📌 **Implicação clínica:** Pacientes com esses fatores de mau prognóstico frequentemente se beneficiam de estratégia **top-down** — ou seja, iniciar com terapias mais potentes desde o começo.

Classes de Medicamentos — Visão Geral

O tratamento farmacológico da DII envolve diferentes classes terapêuticas, cada uma com mecanismo de ação, indicação, perfil de segurança e papel específico no manejo da doença. A escolha adequada depende da fase da doença, do tipo de DII e do perfil individual do paciente.

1

Aminossalicilatos

5-ASA — ação anti-inflamatória local, primeira linha na RCU leve a moderada

2

Corticoides

Potente ação anti-inflamatória sistêmica para indução de remissão em fases agudas

3

Imunomoduladores

Azatioprina, 6-MP, metotrexato — manutenção da remissão e poupadores de corticoide

4

Terapias Biológicas

Anti-TNF, anti-integrinas, anti-IL — revolução no manejo de casos moderados a graves

5

Novas Terapias

Inibidores de JAK e terapias alvo-moleculares — abordagem cada vez mais personalizada

Aminossalicilatos (5-ASA)

O que são os 5-ASA?

Os aminossalicilatos são medicamentos com **ação anti-inflamatória local no intestino**, atuando diretamente na mucosa intestinal sem efeito sistêmico significativo. São considerados a pedra angular no tratamento da Retocolite Ulcerativa leve a moderada.

Mecanismo de Ação

Redução da produção de mediadores inflamatórios como prostaglandinas e leucotrienos, além de inibição de citocinas pró-inflamatórias localmente na mucosa colônica.

Indicações Principais

RCU Leve a Moderada

Tratamento de indução e manutenção da remissão na Retocolite Ulcerativa — principal indicação

Manutenção da Remissão

Eficazes na prevenção de recaídas na RCU, com uso contínuo de longo prazo

Formas de Administração

- **Oral:** Comprimidos e cápsulas com liberação controlada para atingir diferentes segmentos do cólon
- **Tópica:** Enemas e supositórios — indicados em doença distal e retossigmoidiana, com excelente eficácia local

❏ **Na Doença de Crohn:** O papel dos 5-ASA é limitado e controverso na literatura atual. A maioria das diretrizes não os recomenda de rotina para Crohn.

Corticoides — Uso Estratégico e Riscos

Os corticoides são **extremamente eficazes na indução de remissão**, mas representam uma faca de dois gumes: poderosos no curto prazo, prejudiciais quando usados cronicamente. O objetivo moderno é utilizá-los como ponte terapêutica e nunca como estratégia de manutenção.

✓ Vantagens

Ação Rápida

Redução significativa da inflamação em dias, com melhora clínica precoce e marcante

Alto Poder Anti-inflamatório

Eficazes em crises moderadas a graves, com taxa de resposta elevada nas fases agudas

✗ Limitações Fundamentais

Não Mantêm Remissão

Corticoides não são agentes de manutenção — sua retirada frequentemente leva a recaída

Corticodependência

Alguns pacientes não conseguem retirar o corticoide sem recaída — sinal de alarme clínico

⚠ Efeitos Adversos do Uso Prolongado

Osteoporose

Redução da densidade mineral óssea com risco de fraturas por fragilidade

Diabetes e HAS

Alterações metabólicas com hiperglicemia e elevação da pressão arterial

Infecções

Imunossupressão sistêmica com maior suscetibilidade a infecções oportunistas

Alterações Psiquiátricas

Insônia, ansiedade, depressão e psicose corticoide em doses elevadas ou uso prolongado

📌 **Estratégia ideal:** Usar para induzir → retirar gradualmente → substituir por terapia de manutenção adequada. O objetivo atual é **evitar a dependência de corticoides**.

Imunomoduladores

Os imunomoduladores atuam **reduzindo a resposta imune de forma sustentada ao longo do tempo**. São fundamentais na estratégia de manutenção da remissão e como poupadores de corticoides. Seu principal desafio é o tempo de latência para início de efeito — semanas a meses são necessários para a resposta terapêutica plena.

Azatioprina e 6-Mercaptopurina

Antimetabólitos que inibem a proliferação de linfócitos. São os imunomoduladores mais utilizados na DII, especialmente na Doença de Crohn. Exigem monitoramento hematológico regular devido ao risco de mielotoxicidade.

Metotrexato

Alternativa nas situações de intolerância ou falha à azatioprina, com uso predominante na Doença de Crohn. Possui ação anti-inflamatória independente do efeito citotóxico. Uso semanal com suplementação de ácido fólico obrigatória.

Indicações Principais

Manutenção da remissão em longo prazo, redução da corticodependência e corticorresistência. Frequentemente usados em combinação com terapias biológicas para potencializar a resposta e reduzir a imunogenicidade.

 **Importante:** Demoram **3 a 6 meses** para fazer efeito pleno. Nunca devem ser utilizados como única estratégia em crises agudas — sempre associar a um indutor de remissão enquanto aguarda o efeito.

Terapias Biológicas — Revolução no Tratamento

As terapias biológicas **transformaram radicalmente o manejo da DII**, especialmente nos casos moderados a graves que não respondiam adequadamente às terapias convencionais. São moléculas produzidas por biotecnologia que atuam em alvos específicos da cascata inflamatória.



Anti-TNF

Infliximabe e Adalimumabe — bloqueiam o fator de necrose tumoral alfa, uma citocina central na inflamação intestinal. Primeira classe biológica aprovada para DII, com vasta evidência clínica acumulada em mais de duas décadas de uso.

70%

Taxa de Resposta

Resposta clínica aproximada aos anti-TNF em pacientes sem tratamento biológico prévio



Anti-Integrinas

Vedolizumabe — atua especificamente no intestino, bloqueando a migração de linfócitos para a mucosa intestinal. Perfil de segurança favorável por ser gut-selective, sem imunossupressão sistêmica relevante.

50%

Remissão

Taxa de remissão clínica atingida com terapias biológicas em casos moderados a graves



Anti-Interleucinas

Ustequinumabe — bloqueia IL-12 e IL-23, interleucinas envolvidas na diferenciação de células Th1 e Th17. Indicado principalmente na Doença de Crohn moderada a grave com falha prévia a anti-TNF.

3

Classes Disponíveis

Anti-TNF, anti-integrinas e anti-interleucinas — mecanismos de ação complementares

Terapias Avançadas e Novos Fármacos

A Fronteira do Tratamento

A medicina avança rapidamente na direção de tratamentos cada vez mais específicos, com menor toxicidade sistêmica e maior capacidade de personalização terapêutica. Os novos fármacos representam a próxima geração do manejo da DII.

Inibidores de JAK

Tofacitinibe e Upadacitinibe — moléculas pequenas que inibem a via de sinalização JAK-STAT, central na resposta inflamatória.

Administração oral é uma vantagem importante sobre os biológicos injetáveis. Indicados na RCU moderada a grave e, mais recentemente, na Doença de Crohn.

Vantagens das Pequenas Moléculas

Administração Oral

Maior comodidade para o paciente em comparação com biológicos injetáveis ou infusionais

Ação Rápida

Início de efeito mais veloz do que imunomoduladores e comparável aos biológicos

Sem Imunogenicidade

Por não serem proteínas de grande porte, não induzem formação de anticorpos neutralizantes

Abordagem Personalizada

Permitem ajuste de dose e combinação com outros agentes de forma mais flexível

- ❏ Os inibidores de JAK requerem triagem de risco cardiovascular e tromboembólico antes da prescrição — perfil de segurança em monitoramento contínuo.

Estratégias Terapêuticas: Step-up vs Top-down

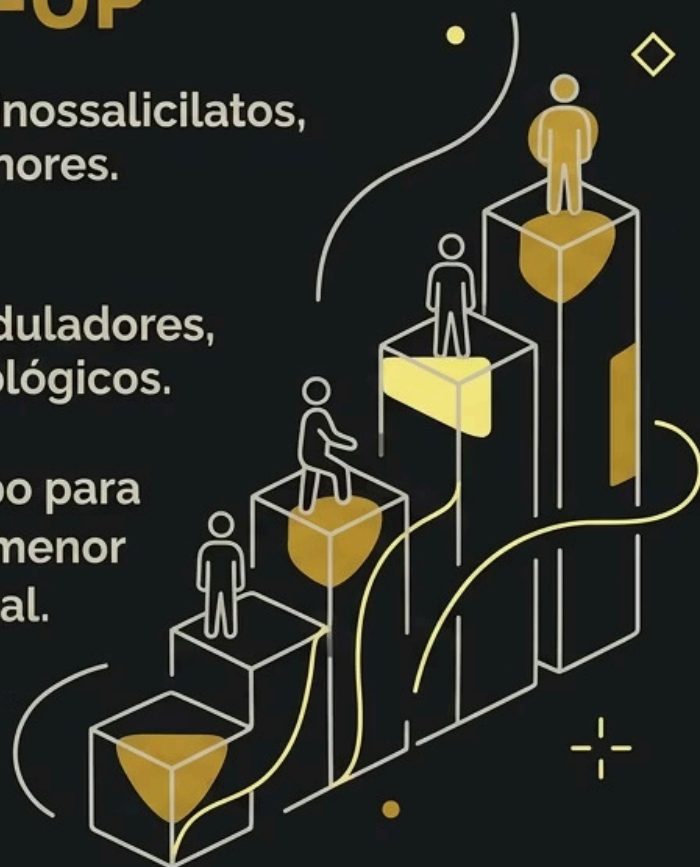
A escolha da estratégia de tratamento é uma das decisões mais importantes no manejo da DII. Não existe uma abordagem única — a decisão deve ser individualizada com base no perfil clínico, prognóstico e preferências do paciente.

ESTRATÉGIA STEP-UP

Início: aminossalicilatos, doses menores.

Escalada: imunomoduladores, depois biológicos.

Mais tempo para controle, menor custo inicial.

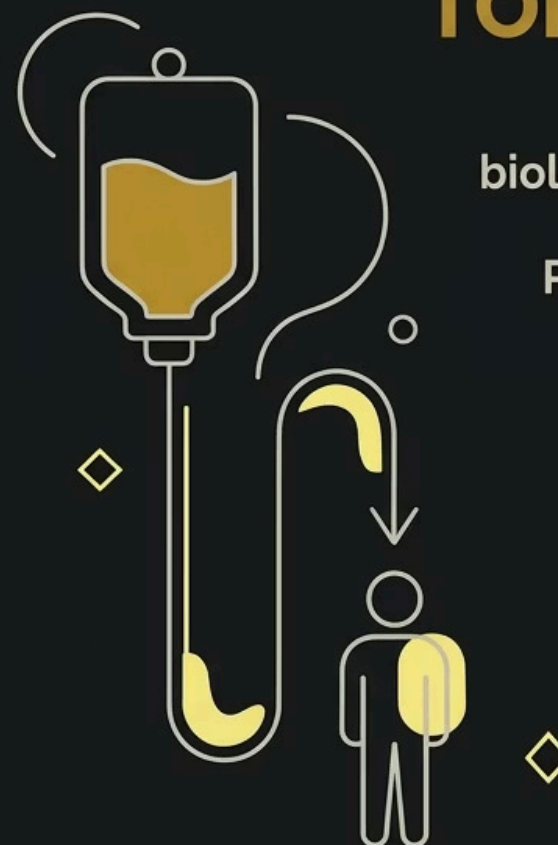


ESTRATÉGIA TOP-DOWN

Início: terapias biológicas potentes.

Pacientes de alto risco, mau prognóstico.

Controle rápido, maior custo, menor risco longo prazo.



Quando optar pelo Step-up?

- Doença leve a moderada sem fatores de mau prognóstico
- Primeiro episódio sem extensão significativa
- Paciente sem complicações estruturais presentes
- Preferência do paciente e considerações de custo-efetividade

Quando optar pelo Top-down?

- Presença de fatores de mau prognóstico (Crohn jovem, perianal, fistulas)
- Pancolite na RCU com inflamação intensa
- Falha rápida ao tratamento convencional
- Doença rapidamente progressiva ou hospitalizações frequentes

📌 **Tendência atual:** As diretrizes internacionais recentes recomendam **expansão do uso da estratégia top-down** em casos selecionados, especialmente na Doença de Crohn com fatores de risco.

Tratamento da Retocolite Ulcerativa por Gravidade

1

● Leve

Aminossalicilatos orais e/ou tópicos (enemas, supositórios). Eficácia elevada na doença distal. Manutenção com 5-ASA contínuo.

2

● Moderada

Corticoides sistêmicos para indução de remissão. Associar imunomodulador para manutenção e poupança de corticoide. Avaliar necessidade de biológico.

3

● Grave

Terapias biológicas (anti-TNF, vedolizumabe) e/ou imunossupressores. Internação hospitalar em casos de crise grave aguda com corticoide IV. Avaliar colectomia de urgência se refratário.

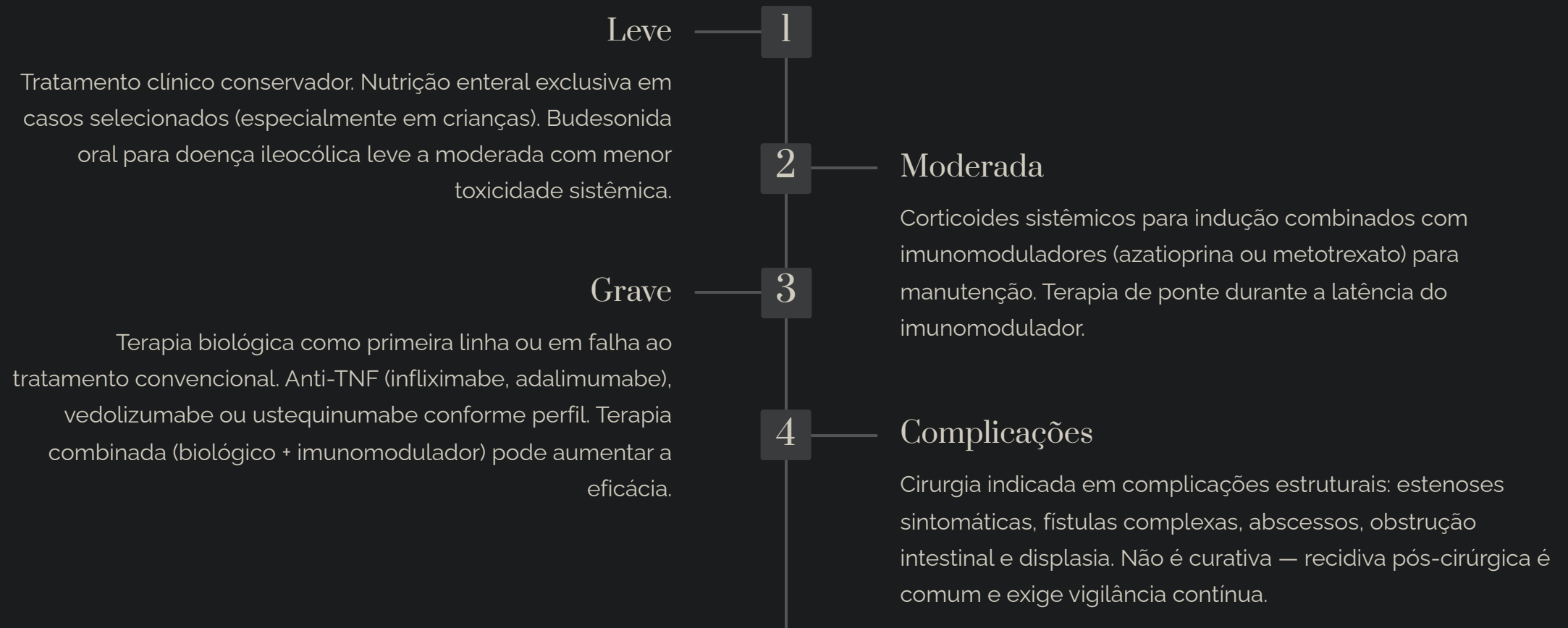
4

● Refratário

Cirurgia — colectomia total com potencial curativo. A retirada do cólon elimina a doença de base na RCU, diferentemente do Crohn. Decisão multidisciplinar e individualizada.

Tratamento da Doença de Crohn por Gravidade

O tratamento do Crohn é mais complexo do que o da RCU, dada a heterogeneidade da doença — diferentes localizações, comportamentos e complicações estruturais exigem abordagens altamente individualizadas.



❏ **Diferença fundamental:** Na Doença de Crohn, a cirurgia **não é curativa** — pode afetar qualquer segmento do trato digestivo. O objetivo cirúrgico é tratar complicações localizadas, preservando o máximo de intestino funcional.

Papel da Cirurgia na DII

◆ Doença de Crohn — Cirurgia Paliativa

Na Doença de Crohn, a cirurgia **não é curativa**, pois a doença pode acometer qualquer segmento do trato gastrointestinal, do esôfago ao ânus. O objetivo é tratar complicações específicas.

→ Indicações Principais

Estenoses fibróticas sintomáticas, fístulas complexas (enteroentéricas, enterovesicais), abscessos intra-abdominais, obstrução intestinal aguda e displasia em segmento comprometido

→ Recidiva Pós-operatória

Altamente frequente — em torno de 70–80% dos pacientes apresentam recidiva endoscópica em 1 ano sem profilaxia medicamentosa adequada. Vigilância pós-cirúrgica é obrigatória.

◆ Retocolite Ulcerativa — Cirurgia Curativa

Na RCU, a **colectomia total pode ser curativa**, pois a doença está restrita ao cólon. A remoção completa do cólon elimina o substrato anatômico da doença.

→ Indicações na RCU

Crise grave refratária a tratamento clínico intensivo, displasia de alto grau ou câncer colorretal, corticodependência ou intratabilidade clínica com impacto severo na qualidade de vida

→ Anastomose Íleo-Anal

Técnica cirúrgica padrão que preserva a função esfinteriana e elimina a necessidade de ostomia permanente na maioria dos casos, com boa qualidade de vida pós-operatória

❏ A decisão cirúrgica deve ser sempre **individualizada e multidisciplinar**, envolvendo gastroenterologista, cirurgião e o paciente.

Visão Final — Manejo Estratégico da DII

A DII deve ser compreendida como uma doença **crônica, progressiva, multifatorial e dinâmica**, que acompanha o paciente por toda a vida. O médico moderno não trata apenas sintomas — ele maneja a evolução da doença ao longo de décadas, prevenindo complicações e preservando a qualidade de vida.



Diagnóstico Precoce

Identificar a doença antes que complicações estruturais se instalem é o primeiro e mais impactante passo no manejo. Atraso diagnóstico aumenta significativamente o risco de estenoses e cirurgias.



Escolha Adequada do Tratamento

Selecionar a terapia certa para o perfil certo do paciente, considerando gravidade, localização, fatores prognósticos e disponibilidade. Personalização é o futuro do manejo.



Monitoramento Contínuo

Avaliação periódica com exames laboratoriais, calprotectina, endoscopia e imagem para detectar atividade subclínica antes que se torne clínica. O silêncio sintomático não é garantia de remissão.



Ajuste Baseado em Metas

Tratar até atingir o alvo — remissão clínica, endoscópica e biomarcadores normalizados. Ajustar ativamente o tratamento se as metas não forem alcançadas dentro do prazo esperado.

Resumo do Módulo — Pontos-Chave

Recapitulando os conceitos fundamentais abordados nas páginas 61 a 80 desta apostila:

1 Objetivos Modernos vão além dos sintomas

Mucosal healing, remissão endoscópica e prevenção de complicações são os alvos reais do tratamento contemporâneo

2 Treat to Target exige monitoramento ativo

Metas objetivas devem ser definidas e avaliadas periodicamente com exames — não apenas com avaliação clínica subjetiva

3 Corticoides são ponte, não destino

Eficazes na indução, mas prejudiciais em longo prazo. Corticodependência é sinal de alarme que exige escalonamento terapêutico

4 Biológicos transformaram o prognóstico

Especialmente em casos moderados a graves, as terapias biológicas e as novas pequenas moléculas mudaram a história natural da doença

5 Cirurgia tem papéis distintos em cada DII

Curativa na RCU (colectomia total), paliativa no Crohn — sempre decisão individualizada e multidisciplinar

Referências e Base Científica

Este módulo foi elaborado com base nas principais referências internacionais e nacionais em Doença Inflamatória Intestinal, garantindo conteúdo atualizado e fundamentado nas melhores evidências disponíveis.

ECCO Guidelines

European Crohn's and Colitis Organisation — diretrizes europeias de referência mundial para diagnóstico e tratamento da DII, atualizadas regularmente com as últimas evidências

Estudos Clínicos em Terapias Biológicas

Ensaio SONIC, GEMINI, UNIFI, VARSITY e outros estudos pivotais que fundamentaram a aprovação e o posicionamento das terapias biológicas no manejo da DII

Literatura Avançada em Gastroenterologia

Publicações do Gut, Gastroenterology, Inflammatory Bowel Diseases e outros periódicos de alto impacto na área de doenças inflamatórias intestinais

Diretrizes Nacionais

Consensos da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG) e do Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil (GEDIIB) — adaptados à realidade clínica brasileira

 Conteúdo elaborado para fins educacionais. A aplicação clínica deve sempre considerar o contexto individual do paciente e ser baseada no julgamento clínico do profissional de saúde responsável.